

• 药物与临床 •

药物相互作用

一、抗感染药物	处 理
青霉素(P): 包括各种青霉素盐 • 氨基糖苷类:在羧苄西林、替卡西林溶液中,易分解损失效价。 • 抗凝血药:多种青霉素有阻碍凝血作用。	分别给予 注意
头孢菌素(C) • 氨基糖苷类:肾毒性增强。 • 维生素 K:头孢哌酮、头孢米诺、头孢美唑、头孢孟多、拉氧头孢、头孢甲肟等可干扰维生素 K 的循环,致出血倾向。 • 乙醇:上述品种的头孢菌素抑制乙醛脱氢酶造成双硫仑反应(醉酒貌)。	肾病患者禁用 注意 禁止联合应用
氨基糖苷类(AG) • 强效利尿药(呋塞米、依他尼酸等):可增强 AG 的耳毒性。 • 耳毒性药物(红霉素、阿司匹林、奎尼丁等):可增强 AG 的耳毒性。 • 肌松药(包括安定类、氯唑沙宗等):神经肌肉阻滞作用加强、可致呼吸肌麻痹意外。 • 头孢菌素:肾毒性增强。 • 右旋糖酐:肾毒性明显增强。	禁止联合应用 慎用 禁止联用 慎用 不宜联用
大环内酯(M):红霉素等 • 茶碱:M 抑制肝酶,阻碍茶碱正常代谢,严重时可引起呼吸抑制。 • 碱性药:口服联用可阻滞 M 的吸收,食物也有阻滞吸收作用。 • 抗组胺药(阿司咪唑、特非那定):M 抑制细胞色素 P-450 酶,阻滞这两种药的正常代谢,加强心脏毒性、增加发生尖端扭转型室性心律失常的发生。 • 西沙必利:心脏毒性增强(参阅上条)。	监测茶碱 分开口服 不宜联用 不宜联用
四环素类:四环素、多西环素、米诺环素、土霉素 • 碱性药、食物:阻滞本类药物的吸收。 • 二价、三价金属离子:严重阻滞本类药物吸收。 • 口服避孕药:改变肠道菌群,妨碍口服避孕药的肠肝循环,降低避孕效果。	避开应用 避开应用 不宜联用,或采取其他避孕措施
多粘菌素类(注射用) 本类药物有肾毒性和神经肌肉阻滞作用(参阅氨基糖苷类)。	
去甲万古霉素(NV) 本品具有耳毒性和肾毒性,参阅氨基糖苷类的有关叙述。	
林可霉素类(L): 包括克林霉素 • 红霉素类:竞争细菌细胞靶位上的结合点,不宜同用。 • 肌松药、中枢麻醉药:L 具有肌松作用,神经肌肉阻滞加强。 • 阿片类:呼吸抑制加强。 • 吸附性止泻药:使 L 吸收减少,L 在肠道中贮留,引起假膜性肠炎(L 类的继发反应)的机会增加。	注意 应特别注意 应监护 特别注意
磺胺类(S) • 对氨基苯甲酸:拮抗 S 的抗菌作用。普鲁卡因、酵母等也有类似作用。	禁忌
呋喃唑酮 本品有单胺氧化酶抑制剂的作用,与下列各药(食物)可引起血压异常升高和高热。 • 含酪胺的食物:包括芸豆、酵母、奶酪、啤酒、酒类(非蒸馏酒),鸡肝等。 • 非直接作用的交感胺类:苯丙胺、麻黄素等。 • 镇静药、抗组胺药、安定药、麻醉镇痛药,可出现体位性低血压与低血糖。	禁忌 禁忌 减量谨慎使用
喹诺酮类(Q) • 口服碱性药:影响本类药物的消化道吸收。 • 抗胆碱药、H ₂ 阻滞药:减少胃酸分泌,不利本类药物吸收。 • 茶碱:Q 抑制细胞色素 P-450 酶,此作用以环丙沙星、依诺沙星、培氟沙星最为显著,其他品种也有不同程度的此种作用,参见红霉素类的有关叙述。	避开应用 不宜联用 检测茶碱

一、抗感染药物	处 理
- 阿司咪唑、特非那定:心脏毒性增强。 - 西沙必利:心脏毒性增强。 - 利福平、氯霉素:使本类药物的抗菌作用减弱。	避免联用 避免联用 不宜联用
甲硝唑(M) - 华法林:抑制代谢,使凝血作用加强。 - 乙醇:抑制乙醇脱氢酶,产生双硫仑反应。替硝唑也有类似反应。	检测凝血功能 避免同用
异烟肼(I) - 含铝抗酸药:抑制本品口服吸收。 - 华法林:正常代谢受抑,凝血作用加强。 - 利福平:异烟肼代谢加速,并可增强肝毒性(此联合可加强抗结核作用)。 - 肾上腺皮质激素(系统用药):加速 I 的代谢,使之降效。 - 苯妥英钠:代谢减慢、血药浓度升高。	应避免同服 监测凝血功能 加强观察 监测苯妥英钠
利福平(R) - 乙醇慢性中毒(嗜酒者):R 的代谢加速,降效,并可产生肝损害。 - 对氨基水杨酸钠(口服):影响 R 的口服吸收。 - 肾上腺皮质激素、抗凝药、华法林、口服降糖药、氨苯砜、洋地黄毒苷、奎尼丁:由于 R 的酶促作用而代谢加速、降效。 - 口服避孕药:代谢加速并阻断肠肝循环而降效,导致避孕失败。 - 苯妥英钠:代谢加速而降效。 - 茶碱:代谢加速而降效。 - 酮康唑、咪康唑(系统给药):肝毒性增强。	临床注意 避开同服 加强观察或监测 改变避孕方法 监测苯妥英钠 监测茶碱 谨慎最好不用
乙胺丁醇(E) - 氢氧化铝:E 的吸收减少。 - 乙硫异烟胺:与 E 或利福平同用,不良反应增多。	不宜同用 不宜同用
氨苯砜(D) - 利福平:使 D 的血浓度大幅度降低而失效。 - 对氨基苯甲酸:D 的抗麻风菌作用减弱,但对疱疹样皮炎的作用则不受影响。	增加 D 用量 临床注意
两性霉素 B(B) - 肾上腺皮质激素:排钾增多,可致低血钾症危险。 - 强心苷类:B 的排钾作用,增强强心苷类毒性。 - 肌松药:低血钾可增强神经肌肉阻滞作用。 - 肾毒性药物:氨基糖苷、多粘菌素、万古霉素、顺铂等与 B 合用,肾毒性增强。	临床注意 监测心功能和血钾 慎用 避免联用
康唑类(C): 酮康唑、咪康唑、伊曲康唑、氟康唑 - 乙醇:肝毒性增强。 - 华法林:血浓度升高,可致意外出血。 - 碱性药、M 受体阻滞药、组胺 H₂ 受体阻滞药:胃内容物中 pH 升高,使本类药物口服吸收减少。 - 异烟肼、利福平:均可使酮康唑血药浓度降低,两药一起联用尤甚。 - 抗组胺药:C 抑制阿司咪唑、特非那定正常代谢,可发生严重心脏反应。 - 西沙必利:C 抑制西沙必利的正常代谢,可发生严重心脏反应。	避免含醇药剂 监测凝血酶原 康唑类需提前 2 小时服用 避免联用 配伍禁忌 配伍禁忌
特比萘芬(T) - 利福平:加速本品代谢。 - 西咪替丁:抑制本品代谢。	
阿昔洛韦(A) - 肾毒性药物:可加重肾损害。 - 丙磺舒:使 A 的排泄减少,半衰期延长,毒性增强。	慎用 谨慎
阿糖腺苷(V) 别嘌呤:抑制黄嘌呤氧化酶,减慢 V 正常代谢,增强毒性。	禁忌
齐多夫定(Z) - 阿昔洛韦:加强神经毒性、出现昏睡、疲劳症状。 - 对乙酰氨基酚、阿司匹林、苯二氮草(安定)类、西咪替丁、保泰松、吗啡、磺胺药、丙磺舒等:抑制本品代谢、可致中毒。	禁忌 禁忌

(待续)